

实证研究

护士主导的认知行为干预对痴呆症照护者抑郁症状的相互作用和应对措施的作用

潘玉琴, 博士, 护士; 陈如意, 硕士, 护士; 和杨东亮, 硕士

ABSTRACT

目前的研究探讨了相互性和应对是否预测和/或调解了护士主导的认知行为干预（NLCBI）对痴呆症患者的护理者的抑郁症状的影响。干预组（ $n = 56$ ）每月接受五次由护士主导的认知行为治疗，每次治疗后都有咨询电话。对照组（ $n = 56$ ）每月接受五次与护士干预人员的简短的一般性谈话。在基线、干预结束和2个月的随访中，收集了关于研究变量和人口统计学的调查问卷。研究发现，改善相互关系（ $\diamond = -0.75$, $p = 0.049$ ）和积极应对（ $\diamond = -2.06$, $p = 0.0001$ ）以及减少消极应对（ $\diamond = 1.43$, $p = 0.001$ ）可以预测NLCBI中护理人员抑郁症状的减少。然而，这些变量都没有对干预效果起到中介作用。建议定期进行心理健康护理干预，重点是加强相互性和主动应对，减少被动应对，以维持照顾者的心理健康。

目标。痴呆症患者的照顾者。

干预措施描述。由护士主导的认知行为课程和随后的咨询电话。**作用机制。**影响照顾者的重新评估，从而提高他们的主动应对能力和相互性，减少他们的被动应对，这直接减少了他们的抑郁症状。

结果。相互性、主动应对和被动应对在NLCBI的影响中起到了预测作用，但不是中介作用。

[Res Gerontol Nurs. 2019; 12(1):44-55.]

痴呆症患者的家庭护理人员经常会出现抑郁症状，因为痴呆症的护理是一种负担，而且持续时间很长。由于照顾者需要密切关注他们的痴呆症患者，并可能成为家庭主妇，所以照顾的情况相对有限。

照顾者与接受者关系的积极质量，对家庭照顾者的心理健康很重要（Park & Schumacher, 2014）。然而，在照顾过程中可能会出现个人之间和/或个人内部的冲突，损害了相互关系。在中国，尽管对残疾人的照顾是

潘博士是副教授，陈女士是浙江省金华职业技术学院的实验室讲师，杨先生是中国河北省沧州医学院的讲师，教师/数学系主任。

作者没有披露任何潜在的利益冲突，无论是财务还是其他方面。该项目获得了金华市科技局的资助（2016-4-017）。

作者感谢洛马林达大学公共卫生学院教授Jerry W. Lee博士阅读本文的早期版本。通讯地址：浙江省金华市五洲街1188号金华职业技术学院副教授潘玉琴，博士，注册护士，321017。

省，中国；电子邮件。1850278205@qq.com。

收到了。2018年9月19日；已接受。November 9, 2018

doi:10.3928/19404921-20181212-01

根据文化传统和法律规定, 家庭主要是一种责任, 随着城市化和以前的计划生育政策, 家庭网络已经减少, 照顾者的支持系统仍然没有得到发展。因此, 家庭照顾者需要有效的应对策略来维持他们的心理健康。

理论框架

Lazarus和Folkman (1984) 的压力和应对理论被用来指导目前的研究设计。压力和应对理论强调个人和他/她周围环境之间的相互关系。压力源被认为是来自于感知到的需求和资源之间的不平衡, 而应对是指个体在管理被评估为耗费或超出个体资源的需求方面的认知和行为努力 (Lazarus & Folkman, 1984)。在应对的过程中, 主要的和次要的评价汇聚在一起, 以确定人与环境的交易对幸福是否重要, 而重新评价则是基于新的信息。Lazarus和Folkman (1984) 认为, 人与环境交易中的认知评估会影响个体的应对行为和健康结果。

认知行为干预 (CBI) 等社会心理项目可能有助于调整照顾者对痴呆症、角色要求和特定社会背景下的dyadic关系的重新评价; 照顾者与这些情况的互动可以使用更积极的情绪和积极的应对技能来调整。因此, 交易中的积极重新评价可能会改善照顾者的应对策略和dyadic关系, 并因此促进照顾者的心理健康 (Zauszniewski, Lekhak, & Musil, 2018)。

对照顾者抑郁症的干预效果中的相互性和应对措施

*互助的作用。*相互性是一种积极的双人关系质量, 被认为是照顾者心理健康的支持资源 (Pan, Jones, & Winslow, 2016)。相互性有四个方面: 感情、互惠、分享愉快的活动和分享价值观 (Archbold, Stewart, Greenlick, & Harvath, 1990)。大量文献表明, 较高的相互性与较少的负担或角色压力、较少的抑郁症状以及压力/护理需求与家庭护理者的心理健康之间的调节或调解有关 (Crist, Pasvogel, Szalacha, & Finley, 2017; Park & Schumacher, 2014; Yang, Liu, & Shyu, 2014)。然而, 很少有

使用CBI等支持性策略来促进照顾者的相互关系的研究, 一些有相关干预措施的研究显示对相互关系或抑郁症的影响并不一致。

Kunik等人 (2017年) 报告说, 在痴呆症护理人员中, 通过加强沟通和使日常活动变得愉快的策略, 相互性得到了改善, 但抑郁症没有。然而, Li、Powers等人 (2012年) 没有发现相互性或抑郁症方面有明显的组别差异, 尽管参加赋权教育项目的护理人员在随访中的角色压力较小。Gonzalez、Polansky、Lippa、Gitlin和Zauszniewski (2014年) 进一步报告说, 在残疾人的照顾者中开展资源丰富的培训项目后, 对这些变量的影响很小。这些研究将相互性和减压作为因变量; 因此, 相互性在照顾者抑郁症干预措施中的作用尚不清楚 (Rausch, Caljouw, & Es, 2017)。

*应对的作用。*应对是一个过程, 在这个过程中, 一个人调动他/她的资源来应对需求。应对策略因人而异, 因情况而异, 但通常被分为主动和被动应对, 或以问题为中心和以情绪为中心的应对 (Lazarus & Folkman, 1984; Xie, 1998)。*主动应对*包括积极的情绪和解决问题的策略, 如寻找解决方案和寻求帮助, 而*被动应对*, 类似于功能障碍性应对, 包括消极的情绪, 如回避和否认, 以及行为, 如使用药物和做白日梦 (Li, Cooper, Bradley, Shulman, & Livingston, 2012; Roche, MacCann, & Croot, 2016)。证据显示, 更积极的应对方式减少了照顾者的抑郁症状, 而更被动/功能障碍的应对方式则增加了抑郁症状 (Chan & Chui, 2011; Lu, Liu, Wang, & Lou, 2017; Roche, Croot, MacCann, Cramer, & Diehl-Schmid, 2015)。

一些研究探讨了认知行为疗法 (CBT) 对照顾者应对策略的影响, 但结果各不相同。研究得出三种不同的结果。

(a) 主动应对策略得到改善 (Fialho, Koenig, dos Santos, Barbosa, & Caramelli, 2012; Mahmoodi, Khani, Banab, & Bagheri, 2016); (b) 积极和失调的应对策略增加 (Li, Cooper, Austin, & Livingston, 2013); 以及 (c) 主动应对策略增加, 而被动应对策略选择性减少 (Losada, Marquez-Gonzalez, & Romero-Moreno, 2011)。这些不一致提出了应对策略在CBT对照顾者的抑郁症状的影响中是否起作用的问题。

此外，几个相关的研究结果在CBT如何缓解照顾者的抑郁症方面存在冲突。Gallagher-Thompson, Gray, Dupart, Jimenez和Thompson (2008) 的报告显示，CBT在非西班牙裔白人和西班牙裔拉美人的痴呆症照顾者中通过技能的使用和帮助发挥作用。然而，Li等人 (2014年) 发现，在基线抑郁程度较高的照顾者中，应对技能干预的效果是由以情感为中心的应对方式的增加所介导的，以问题为中心的应对方式和功能障碍的应对方式都没有发挥作用。Losada等人 (2011年) 的一项类似研究表明，这种效果是通过改变照顾者的功能失调思想而发生的。因此，由于照顾者对干预的反应可能不同，需要进行更多的研究来阐明应对是否是成功的CBT干预的中介。

目的

很少有证据表明，在护士领导的社会心理项目对照照顾者的心理健康的影响中，相互性和应对的作用。本研究的目的是探讨互助和应对是否能预测或调解护士主导的CBI (NLCBI) 对残疾人家庭护理者的抑郁症状的影响。在具有类似护理负担和社会经济背景的国家 (如中国)，可以制定护理策略和社会政策来维持护理人员的心理健康。

方法

研究设计和样本

本研究是一项经金华市科技局批准的随机对照试验，包括对人的再观察。通过居民和工作人员的推荐，从中国东南某市的社区卫生中心和三甲医院的神经科招募了家庭护理人员。护理人员被招募的条件是：

- 1:
 - (a) 是主要照顾者；(b) 年龄在20岁或以上。
 - (c) 为被诊断为阿尔茨海默病或痴呆 (包括血管性痴呆) 的家庭成员提供护理，或迷你精神状态检查 (MMSE) 得分 ≤ 17 ；(d) 居住在城市或周边地区的社区。
 - (e) 在流行病学研究中心抑郁量表 (CES-D) 上的抑郁评分 ≥ 10 和 < 20 ，以便对干预和消除医疗或疗法有更好的反应；以及 (f) 能够说或理解中文 (普通话)。
- 被访者被排除在外，因为被访者的病史和记录被重新筛选。

如果他们有自杀倾向，有精神障碍病史，有智力缺陷的迹象，和/或正在接受社会心理治疗和药物治疗，那么他们就会成为搜索者。

样本量

G*power在F检验、两个独立组的三次重复测量、效应大小=0.25、功率=0.85、测量之间的预期 $r=0.5$ 的情况下达到了98个样本量。效果大小是根据系统回顾和荟萃分析决定的，系统回顾和荟萃分析显示CBT对照顾者的抑郁症有小到中等的效果 (刘, 2017)。而大多数社会心理研究的减员率为5%至30% (Cheng等人, 2017; Losada等人, 2015)，根据Waldorff等人 (2012) 在6至12个月随访中11%至20%的减员率，目前的研究采用了15%的减员率。因此，样本量最终确定为112人。

程序

该项目从社区卫生中心和医院的当局获得了进入研究地点的许可。传单和口碑被用来解释该项目和其招募标准。研究员 (Y.P.) 在转介后与潜在的受访者联系，确认资格，获得口头同意，并帮助安排基线调查的预约。五位训练有素的研究助理在时间1 (基线)、时间2 (5个月的干预结束) 和时间3 (2个月的随访) 进行匿名的面对面调查，如果方便的话，可以在照顾者的家里或在医院的病房里进行。再搜索助理接受了调查程序和采访技巧的培训，并得到了可能的问题的答案。在研究人员的监督下，他们成功地演示了调查程序后，就有资格进行调查。护理人员被要求填写问卷，如果需要，研究助理会帮助护理人员阅读问卷。患者的MMSE由研究助理评估。

问卷完成后被收集起来。初步评估后，护理人员被数据处理员通过电脑随机号码随机分配到干预组或对照组，每组有56名护理人员。研究人员最初对研究分配是盲目的，但对干预措施进行监督；数据收集员对治疗分配是盲目的；护理人员收到一封带有分配号码的密封信件，并在干预措施开始时被告知他们的待遇。照料者被分配到以下其中之一

五位训练有素的护士干预者，按地理位置划分。护士干预者不可能进行掩饰。收集的数据被锁在研究者办公室的抽屉里，数据文件被加密并存储在研究者的个人电脑上。

认知行为干预组和对照组

干预组。该NLCBI包括每月初在护理人员家中进行的五次60分钟的单独课程，并在月中进行20至30分钟的咨询电话。干预和随访的时间是根据干预效果的时间和受访者的保留情况来决定的。五名护士接受了关于干预方案和社会心理沟通技术的培训。虽然护士们被要求遵守协议，但允许最小的灵活性以适应个别护理人员。在一个使用微信软件的电子聊天室里建立了一个讨论组，供护士干预者之间交流，以确保干预的一致性。在最初的治疗中，护理人员同意在错过治疗后的几天内补上一次治疗。

干预环节的内容是根据Aboulafia-Brakha, Suchecki, Gouveia-Paulino, Nitrini, and Ptak (2014) ; Cheng等人 (2017) ; 以及Schinköthe和Wilz (2014) 介绍的认知行为策略构建并为中国护理人员定制的。会议1评估了照顾者的情况和对照顾相关问题的看法。第二部分主要是澄清照顾者的压力源、评估和应对策略。第三部分主要集中在认知训练上，教导照顾者积极的重新评估策略，特别是寻找好处（即以积极的方式看待具有挑战性的情况）。在第四节课中，照顾者接受了积极应对行为的培训，如寻求帮助和培养健康的关系，以及避免消极应对行为。第五节课为照顾者提供了放松和自我维护的技能。会议开始时与照顾者建立融洽的关系，结束时对会议进行总结并布置家庭作业。**表1**中列出了在面对面的干预课程中使用的问题。

在双方同意的情况下，安排了20至30分钟的咨询电话，以评估照顾者最近的状况，要求反馈，并加强会谈中所教授的策略。干预人员准备回答照顾者的问题。尽管随后的会议仍然遵守了

在协议中，寻求照顾者的反馈以帮助进一步澄清干预的细节。没有使用留置奖励，因为减员可以部分反映出干预的有效性。

对照组。对照组的护理人员在每个月的月初都会与一名护士干预人员进行五次简短（5至10分钟）的一般性谈话，可以在护理人员的家中、医院或通过电话进行，只要方便。没有深入的指导；谈话是关于护理人员的日常生活和健康的闲聊。

措施

抑郁。10个项目的CES-D被用来评估自由护理人员中抑郁症状的频率。一个项目的例子是“我感到抑郁”。项目的评分采用4点回应格式，从0（很少或没有）到3（大部分时间或全部时间）。量表得分是各项目得分的总和，≥10分表示有临床抑郁症存在。CES-D中文版在中国护理人员中的Cronbach's alpha为0.79（Pan等人，2016）。

相互性。由15个项目组成的相互性量表被用于衡量照顾者的相互性。一个项目的例子是“你在多大程度上享受你们两个人在一起的时间？”项目的评分采用5点李克特量表，范围从0（完全没有）到4（非常多）。量表得分是各项目得分的平均值；得分越高，表明相互关系的水平越高。该量表的中文版本在中国护理人员中的Cronbach's alpha值为0.91（Pan等人，2016）。

简化应对量表。由20个项目组成的简化应对量表应对量表。(Xiao, 1998年) 被开发出来，以衡量应对能力。Cronbach's alpha为0.90。

全量表为0.90，积极应对的12项分量表为0.89，消极应对的8项分量表为0.78。项目的例子包括“向朋友和亲戚寻求建议”和“接受现实，因为没有其他选择”。项目以4分制评分，范围从0（从不使用）到3（经常使用）。子量表的分数是其各自项目的平均分。主动应对的分数越高，说明应对能力越强，而被动应对的分数越高，说明应对能力越差。

日常生活活动（ADL）量表测量病人自我维持的基本和更复杂的活动。其中一个项目的例子是“你吃饭有困难吗？”这些项目以4分制评分，从1分（执行无困难）到4分（无法执行）。

表1

引导认知行为干预的面对面会议的关键问题

会议编号和目标	所提问题
第一场会议 了解照顾者的情况和看法	1. 请您介绍一下自己，并说明您的护理背景（社会经济地位、护理历史、家庭网络、护理需求和支持）？ 2. 你如何看待痴呆症、痴呆症患者、你作为痴呆症照顾者的角色、你的家庭或双方关系、你可获得的支持以及你对这些支持的利用？ 3. 你是否感受或经历过痴呆症的社会耻辱？
第2场 澄清照顾者的压力源、评估和应对策略	1. 请您列举一些困难的护理场景，您以前的管理方法，以及这些方法的后果。 2. 请你反思上述这些情景，并确定压力源、你的评估和应对策略。 3. 你是否意识到积极的评价和积极的应对策略可能减少了你的压力，促进了你解决问题的能力，以及消极的评价和被动的应对策略，可能会增加你的压力？
第三次会议 引发积极评价，避免消极评价	1. 请你回忆几个最愉快或最不愉快的护理场景，并讨论你在这个过程中的积极或消极评价？例如，你通常认为痴呆症护理和双方关系是消极的还是积极的？ 2. 请你分析一下那些愉快的护理场景，并确定使用寻找利益的策略？例如，在这个过程中，你是否体验到了好处或收获？ 3. 请你尝试将寻找利益的策略应用到不快乐的照顾场景中，避免负面情绪，并想象如果后果会更好吗？
第四次会议 训练照顾者使用积极的应对行为，避免消极的应对行为	1. 请你进一步探讨最愉快或最不愉快的护理场景，并讨论你在这个过程中主动或被动的应对行为。 2. 请你尝试将积极的应对行为应用于最困难的护理场景，如建立支持、寻求帮助、培养良好的双人关系或友好的护理环境，想象一下结果是否会更好？ 3. 你是否希望在其他具有挑战性的护理场景中强化这些积极的应对行为，同时避免使用消极的应对行为，如药物使用和回避？
第五次会议 对照顾者进行放松和自我维护的技能培训	1. 你使用哪些放松技巧？请列出可能对你实用的放松技巧。 2. 请你现在花些时间练习放松技巧，如深呼吸、写日记、听音乐、运动、扔软枕头等。 3. 你知道如何管理你的时间，恢复愉快的活动或爱好，平衡营养，并获得更好的睡眠吗？
	4. 你还可以发展哪些个人技能，可能对你的健康有益？

量表得分是各项目得分之和。在中国家庭照顾者中使用了中文版的14项ADL量表（ADL-C），其Cronbach's alpha为0.97（Pan等人，2016）。

*护理对象的迷你精神状态检查。*我们使用中文版的MMSE来评估患者的认知功能。这个工具已经过广泛的测试，具有令人满意的心理计量学，并应用于老

年人。

中国 (Yu, Li, & Huang, 2012)。MMSE包括10个认知功能领域，如记忆、定向和计算，最高分是30分。分数越高说明认知功能越好。对于小学及以下的人来说，诊断认知障碍的临界点是16-19分；因此，本研究采用了17分的临界点 (Yang等人, 2016)。

人口统计学和照顾者的特征。研究人员设计了一份调查问卷，用于收集照顾者和接受照顾者的人口统计学数据。

数据分析

采用SPSS 25.0进行数据分析。采用missForest方法 (Stekhoven & Bühlmann, 2012) 来替换缺失的数据，包括完成研究的个人的一些缺失问题和退出研究的个人的缺失问卷，以便替换后的数据能够最好地反映真实数据的性质。描述性数据是用频率或中心趋势测量来评估的。干预组 and 对照组之间，以及完成研究的人和退出研究的人之间的数据和研究变量的基线比较，根据变量类型和是否符合假设条件，采用卡方检验、独立样本 t 检验或曼-惠特尼 U 检验进行分析。

广义线性混合模型 (GLMM) 被用来分析NLCBI对照顾者抑郁症状的影响，以及相互性、主动应对和被动应对在这种干预效果中的预测作用。这种分析允许同时探讨固定和随机效应。研究变量的重复测量 (时间1、时间2和时间3) 被重新结构化。组别、时间、组别和时间的交互作用以及所研究的变量被输入到固定效应模型中，考虑到护理人员的性别以及患者的ADL和MMSE评分的协变量，根据它们与基线抑郁症状评分的显著性进行初级筛选。时间变量被置于随机模型中，重建的抑郁症分数是因变量。呈现的是 $\diamond$ 和 p 值。

为了探索相互性、主动应对和被动应对的潜在中介效应，按照Murphy、Cooper、Hollon和Fairbum (2009) 的建议，以及类似研究的应用 (Li、Cooper等人, 2014; Losada等人, 2011)，采用了Baron和Kenny (1986) 的程序。通过各自的回归分析，调解人需要满足以下条件：(a) 自变量 (干预组) 的变化必须说明调解人 (相互性、主动应对或被动应对) 的变化；(b) 因变量的变化必须说明下位变量 (抑郁症状) 的变化；以及 (c) 在自变量和调解人上重新强调因变量的同时，自变量必须减少甚至失去对因变量的影响。

而调解人必须保持其影响因变量的重要性。研究变量的变化分别通过从时间2 (T2) 或时间3 (T3) 的分数中减去时间1 (T1) 的分数来计算。控制的协变量与GLMM中的协变量相同。

结果

本研究于2016年5月至2017年3月在中国东南的一个城市进行。残疾人的家庭照顾者 ($N=112$ ；干预组 $n=56$ ，对照组 $n=56$) 从转介的276名照顾者中招募，在时间1进行评估。在时间2，99名照顾者 (干预组 $n=54$ ，对照组 $n=45$) 完成了调查；在时间3，82名照顾者 (干预组 $n=47$ ，对照组 $n=35$) 完成了全部三项评估。在干预组的退出者中，2名护理人员的残疾人死亡，6名护理人员停止了护理工作，1名护理人员搬迁；在对照组中，7名护理人员的残疾人死亡，3名护理人员停止了护理工作，8名护理人员搬迁，3名护理人员拒绝重复调查。

表2列出了家庭照顾者和残疾人的人口统计资料。干预组和对照组的基本特征没有发现明显差异。表3列出了研究变量的平均数和标准差。独立样本 t 检验表明，在时间2和时间3，抑郁症状和积极应对方面的组间差异是显著的。

在表4中，GLMM的固定模型显示：。在控制了协变量后，NLCBI能有效地减少照顾者的抑郁症状 (组与时间的交互作用， $\diamond = 1.12$, $p = 0.0001$)。单独的组别几乎是显著的 ($\diamond = 1.41$, $p = 0.053$)，但时间对减少抑郁症状是非常显著的。主动应对 ($\diamond = -2.06$, $p = 0.0001$) 和被动应对 ($\diamond = 1.43$, $p = 0.001$) 都强烈地预测了照顾者在这个NLCBI中的去压迫症状，而相互性是一个较弱的预测因素 ($\diamond = -0.75$, $p = 0.049$)。

如表5所示，在调整协变量后，T2T1或T3T1的积极应对变化在NLCBI对照顾者相应的去压迫症状变化的影响中没有起到中介作用。在调整协变量后，NLCBI对照顾者的消极症状的影响没有起到中介作用。群体 (自变量) 的重要性并没有因为在模型中加入积极应对 (潜在的中介) 的变化而受到影响 (积极应对。T2 T1 [$p = 0.002$], T3 T1 [$p = 0.028$]; 团体：两个模型中的 $p < 0.0001$)。互助和被动应对不符合作为调解人的第一个条件。团体不是一个显著的变量，在

变化的	n (%)			统计学检验 (<i>p</i> 值)
	共计基线时的参与者特征 (<i>n</i> = 56)	干预组 (<i>n</i> = 56)	对照组 (<i>n</i> = 56)	
护理人员				
年龄(岁)(平均[SD])	62.68 (10.86)	63.27 (11.22)	62.09 (10.56)	<i>t</i> = 0.57 (0.57)
性别				$\chi^2 = 2.44$ (0.12)
女性	70 (62.50)	31 (55.36)	39 (69.64)	
男性	42 (37.50)	25 (44.64)	17 (30.36)	
与接受护理者的关系				$\chi^2 = 0.14$ (0.71)
配偶	54 (48.21)	28 (50)	26 (46.43)	
其他家庭成员	58 (51.79)	28 (50)	30 (53.57)	
教育水平				$\chi^2 = 0.001$ (0.99)
初中及以下	100 (89.29)	50 (89.29)	50 (89.29)	
高中及以上学历	12 (10.71)	6 (10.71)	6 (10.71)	
慢性病的数量 (平均[SD])。	1.08 (1.13)	1.31 (1.29)	0.86 (0.90)	<i>Z</i> = -1.89 (0.07)
护理时间 (月) (平均[SD])。	67.25 (75.58)	71.2 (85.57)	63.27 (64.61)	<i>Z</i> = -0.52 (0.60)
护理对象				
年龄(岁)(平均[SD])	79.48 (9.54)	79.00 (9.35)	79.96 (9.78)	<i>t</i> = -0.53 (0.60)
性别				$\chi^2 = 3.12$ (0.08)
女性	71 (63.39)	40 (71.43)	31 (55.36)	
男性	41 (36.61)	16 (28.57)	25 (44.64)	
ADL得分 ^a (平均[SD])。	43.91 (10.54)	42.93 (10.70)	44.89 (10.38)	<i>t</i> = -0.98 (0.33)
MMSE得分 ^b (平均[SD])。	6.54 (5.87)	6.45 (5.87)	6.64 (5.91)	<i>t</i> = -0.18 (0.86)

注。ADL = 日常生活活动；MMSE = 迷你精神状态检查。*Z*值的计算采用Mann-Whitney U检验。
^a分数从14到56不等，分数越高表示从事ADL的能力越低。
^b分数范围从0到30，分数越高表示认知功能越好。

T₂ T₁ 变化的各自模型的相互性 ($\diamond = 0.13, p = 0.20$) 和被动应对 ($\diamond = -0.04, p = 0.69$)。他们T₃ T₁ 变化的模型取得了类似的结果。因此，没有必要进行进一步的分析。

由于对照组的减员率 (37.5%) 高于干预组 (16%)，因此对完成干预 (*n* = 82) 和退出干预 (*n* = 30) 的人进行了比较分析，并对双方的主要基线特征进行了分析。在照顾者的性别 ($\chi^2 = 0.58, p = 0.49$)、与照顾者的关系 ($\chi^2 = 2.19, p = 0.20$) 或抑郁症状 (*t* = 0.57, *p* = 0.57) 方面没有发现显著的组别差异；或病

人的年龄 (*t* = -0.23, *p* = 0.82)、性别 ($\chi^2 = 0.01, p = 0.99$)、ADL得分 (Mann-Whitney

U, $p = 0.051$), 和MMSE分数 (Mann-Whitney U, $p = 0.70$)。然而, 年轻的照顾者 (平均年龄=58.93岁, $SD=9.08$ 岁) 比年长的照顾者 (平均年龄=64.05岁, $SD=11.18$ 岁; $t=-2.25$, $p=0.037$) 更容易退出。

讨论

与文献中的发现一致 (Hopkinson, Reavell, Lane, & Mallikarjun, 2018; Liu, 2017), 该NLCBI被发现对照顾者的抑郁症有治疗作用, 因为照顾者的相互性和应对方面的有利变化起到了关键作用。由于目标人群中很少有护士进行类似的研究, 这一发现丰富了研究领域, 并告知当局, 社区的CBI

变化的	平均值 (SD)		
	基准线	干预结束	2个月的跟踪调查
不同时期研究变量的平均数、标准差和t分数			
相互关系a (t检验)	0.01	1.47	1.47
干预组	1.15 (0.40)	1.33 (0.59)	1.27 (0.54)
控制组	1.15 (0.51)	1.19 (0.42)	1.13 (0.50)
积极应对b (t测试)	-0.37	4.63***	2.92**
干预组	1.15 (0.40)	1.65 (0.45)	1.45 (0.43)
控制组	1.18 (0.37)	1.28 (0.38)	1.24 (0.32)
被动应对b (t检验)	-0.21	-0.65	0.54
干预组	1.38 (0.42)	1.24 (0.38)	1.13 (0.39)
控制组	1.39 (0.35)	1.29 (0.32)	1.09 (0.30)
抑郁症状c (t测试)	1.15	-4.00***	-3.35**
干预组	13.93 (3.45)	9.40 (3.39)	10.19 (2.78)
控制组	13.21 (3.11)	11.96 (3.40)	12.21 (3.56)

注。数据是基于N=112, 干预组n=56, 对照组n=56。干预结束时的实际样本量为N=99, 干预组n=54, 对照组n=45。2个月随访时的实际样本量为: N=82, 干预组n=47, 对照组n=35。缺失的数据用missForest方法替换。

^a使用15个项目的相互性量表进行测量。项目得分从0到4不等, 得分越高表明相互性水平越高。

^b使用20个项目的简化应对量表进行测量, 项目分数从0到3不等。主动应对(12个项目)的分数越高表示应对越好, 而被动应对(8个项目)的分数越高表示应对越差。

^c使用流行病学研究中心的10项抑郁量表进行测量。分数范围从0到30, 分数越高表示抑郁症状越多。

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001。

在缺乏足够数量的初级医师的国家, 护士可以维护护理人员心理健康。

被研究的变量在干预效果中的作用

相互关系。在调整协变量后, 相互性被认为是NLCBI中照顾者抑郁症状的一个重要预测因素, 尽管很弱。认知训练被发现可以提高照顾者对伴侣间相互性的评价 (Li, Powers, et al., 2012), 而较高的相互性被认为可以减轻照顾者的抑郁 (Crist et al., 2017; Ostwald et al., 2014)。然而, 在NLCBI组中, 照顾者的相互性只有轻微增加, 这与Kunik等人 (2017) 的发现一致, 但与Gonzalez等人 (2014) 和Orrell等人 (2017) 的发现相反。这些差异可能是由于类似研究之间的策略多样性: 例如, 目前的NLCBI并没有完全关注相互性, 而是将其作为干预的一个方面。

此外, 相互性的小幅增加有助于解释其在NLCBI的老年护理学研究》--第12卷, 第1期, 2019年

有效性中的非中介作用, 有一些促成因素。目前的研究中, 认知功能差的残疾人可能已经失去了他们的能力。

深入互动或互惠的能力，这可能已经损害了照顾者的相互性（Park & Schumacher, 2014）。此外，在目前的研究中，照顾者是中度抑郁的，这可能会降低他们与没有抑郁的照顾者的相互性（Shim, Landerman, & Davis, 2011）；这可以解释照顾者对NLCBI的反应迟缓。尽管这一发现增加了对这一主题的了解，但未来的调查可以将干预的重点放在认知障碍较少的残疾人的照顾者中，从而帮助更好地了解相互性的动态及其作用。

积极应对。目前的研究表明，在调整协变量后，积极应对的增强强烈地预测了患有NLCBI的照顾者中抑郁症状的减少，这一发现得到了类似研究的支持（Cheng等人，2017；Li等人，2014）。这种NLCBI部分涉及照顾者对照顾需求和文化障碍的看法，如痴呆症的社会耻辱和照顾者不愿意在中国的社会背景下寻求帮助。照顾者对上述问题的重新评估可能变得更加积极，他们的积极应对策略也得到了改善，从而减少了照顾者的负担。

表4

广义线性混合模型中相互性、主动应对和被动应对对照顾者抑郁症状的固定影响（N = 112）。

预测变量	抑郁症状	
	β	p值
拦截	3.18	0.18
照顾者性别	1.02	0.044*
患者的日常生活活动得分	0.07	0.009**
患者的迷你精神状态检查得分	0.13	0.007**
集团	1.41	0.053
添雅		
干预结束	3.70	0.0001***
2个月的随访	4.93	0.0001***
第X组时间	1.12	0.0001***
相互性	-0.75	0.049*
积极应对	-2.06	0.0001***
被动应对	1.43	0.001**

，是将它们的基线、干预结束和2个月的随访分数结合起来的重构变量。

以基线时间为参考组。

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001。

(Lazarus & Folkman, 1984)。因此，定期的、有针对性的心理健康护理干预措施，如这个NLCBI，对缓解发展中国家护理人员心理压力很有帮助。

然而，在目前的研究中，没有发现积极应对在干预效果中起到中介作用，这与Gallagher-Thompson等人（2008）的发现相矛盾，但与Li等人（2014）的报告部分一致。目前的研究没有像以前的研究那样包括技能利用的中介变量，而且情绪应对没有与行为应对分开测量；然而，这些中介因素中包括的应对策略可以反映在目前研究中的积极应对的尺度中。不同的研究设计，包括使用不同的量表，可能导致了这些研究之间的不一致。因此，积极应对的中介作用可以通过重复这项研究得到澄清。

被动应对。在调整协变量后，被动应对的减少预示着接受NLCBI的护理人员的抑郁症状会减少。正如López-Martinez（2008）所示，接受社会心理干预的护理人员认为社会支持较高，因此以较少的被动应对策略应对。然而，本研究中被动应对的减少与Li等人（2014）的类似研究结果相反，但与Losada等人（2015）的发现一致。这些不同的结果可能是由于来自不同文化背景的照顾者的反应，或者使用了混合量表：被动应对、功能障碍应对或情绪集中应对。

此外，被动应对的变化不可能在干预效果中发挥中介作用，因为中介条件没有得到满足。这可能是由于NLCBI更注重利益的寻找，这主要是训练照顾者有积极的想法，因此，使用更积极的应对策略，这可能会对被动应对的影响较小。尽管如此，值得注意的是，两组的策略（干预组和控制组）在影响照顾者的被动应对方面可能同样有效（如t检验所示）。因此，本研究提供了第一手资料，说明中国护理人员如何通过心理健康护理干预减少被动应对来缓解抑郁症。然而，由于参考文献较少，这一机制值得在目标人群中进一步证实。

限制条件

本研究探讨了一个很少被调查的话题--相互性和应对性在中国痴呆症护理者无障碍环境有效性中的预测和中介作用。然而，这项研究也有局限性。

首先，虽然用MissForest方法替换了缺失的数据，但对照组的高减员率以及完成和退出研究的个人之间的年龄差异可能会影响到最终结果。在本研究中，患有抑郁症的护理人员倾向于停止护理工作；在中国，年轻的护理人员可能有其他竞争性的角色，如养育孩子，并且容易搬迁；而状况不佳的残疾人往往不能活过三个调查阶段。未来的研究应该选择那些更有可能完成研究的受访者，并制定激励措施来留住照顾者。

第二，本研究中没有包括无治疗的比较组。有可能部分的

表5 积极应对的调解分析 (N= 112)。					
回归分析	独立变量	因变量		t 测试	p值
	用于T2T1变化的模块				
1	干预组	积极应对的变化	0.41	4.58	0.0001***
2	干预组	抑郁症状的变化	-0.48	-5.58	0.0001***
3	干预组	抑郁症状的变化	-0.36	-4.03	0.0001***
	积极应对的变化		-0.28	-3.17	0.002**
	用于T3T1变化的模块				
1	干预组	积极应对的变化	0.27	2.88	0.005**
2	干预组	抑郁症状的变化	-0.39	-4.29	0.0001***
3	干预组	抑郁症状的变化	-0.33	-3.61	0.0001***
	积极应对的变化		-0.21	-2.22	0.028*

注：T1=时间1（基线）；T2=时间2（干预结束）；T3=时间3（2个月随访）。T2T1=T2得分-T1得分；T3T1=T3得分-T1得分。所有回归模型控制了照顾者的性别、病人的日常生活活动得分和迷你精神状态检查得分。

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001。

干预效果仅仅是由于护士的注意；此外，相关的变量，如感知社会支持没有包括在内，这可能会导致有偏见。因此，建议在未来的研究中加入无治疗组进行观察，并加入感知的社会支持这一混杂变量。

未来研究的意义和方向

从目前的研究中得到了一些启示。本研究部分支持 Lazarus和Folkman（1984）的压力和应对理论，因为积极应对被发现是干预效果的一个预测因素，而不是一个调解因素。NLCBI很可能对照顾者的重新评估起作用，这反过来又提高了照顾者的积极应对技能和相互性，减少了他们的消极应对，并最终减少了他们的抑郁症状。

在护理实践方面，这项以面对面会议和电话咨询为特点的NLCBI有利于减少精神上的压力。

抑郁的、在家的残疾人护理者的压力。这种方法可以进一步发展，社区护士应该接受使用这种方法的培训。

对于护理研究来说，类似的研究设计可以在控制减员率的同时进行更长的观察期。旨在改善护理人员相互关系的研究值得进一步探讨，并且需要确认相互关系或应对的中介作用。最后，可将感知的社会支持作为一个潜在的中介因素。

中国的痴呆症社会政策已经到了一个关键的阶段，是时候承认家庭护理人员的贡献了。支持家庭护理人员将产生重大影响，因为护理人员的福祉有助于维持家庭对残疾人的护理，这反过来又大大减少了国家的财政保健投资。因此，应该启动心理健康护理服务，如NLCBIs，以满足护理人员的心理需求。这些服务也可以与其他社会政策相结合，以应对痴呆症护理的危机。

结论

在NLCBI中,改善相互关系和积极应对以及减少被动应对在缓解残疾人家庭护理者的抑郁症状方面起到了预测作用,但不是中介作用。这项研究为干预机制的初步发现做出了贡献。建议在与中国社会经济背景相似的国家,通过心理健康护理项目和支持性的社会政策来提高照顾者的互助性和主动应对能力,并减少被动应对以维持照顾者的心理健康。

参考文献

- Aboulafia-Brakha, T., Suchecki, D., Gouveia-Paulino, F., Nitrini, R., & Ptak, R. (2014). 认知行为团体疗法改善了阿尔茨海默病患者护理者的压力心理生理指标。 *Aging & Mental Health*, 18, 801-808. doi:10.1080/13607863.2014.880406
- Archbold, P.G., Stewart, B.J., Greenlick, M.R., & Harvath, T. (1990). 互助性和准备性是护理人员角色紧张的预测因素。 *Doi:10.1002/nur.4770130605*.
- Baron, R.M., & Kenny, D.A. (1986). 社会心理学研究中的调节器-中介变量的区别。概念、策略和统计方面的考虑。 *人格与社会心理学杂志*, 51, 1173-1182. doi:10.1037/0022-3514.51.6.1173
- Chan, C.L., & Chui, E.W. (2011). 文化因素与香港体弱老人的华人配偶照顾者的照顾负担之间的关系。 *doi:10.1080/13607863.2010.536139*.
- Cheng, S.T., Mak, E.M., Fung, H.H., Kwok, T., Lee, D.F., & Lam, L.W. (2017). 效益的发现和对照照顾者抑郁症的影响。一个双盲的随机对照试验。 *咨询与临床心理学杂志*, 85, 521-529. doi:10.1037/ccp0000176
- Crist, J.D., Pasvogel, A., Szalacha, L.A., & Finley, B.A. (2017). 墨西哥裔家庭照顾者的抑郁症。因压力而加剧,因相互性而减轻。 *Research in Gerontological Nursing*, 10, 106-113. doi:10.3928/19404921-20170412-01
- Fialho, P.A., Koenig, A.M., dos Santos, M.D.L., Barbosa, M.T., & Caramelli, P. (2012). 痴呆老人家庭护理人员的认知行为干预方案的积极影响。 *Arquivos De Neuro-Psiquiatria*, 70, 786-792. doi:10.1590/S0004-282X2012001000007
- Gallagher-Thompson, D., Gray, H.L., Dupart, T., Jimenez, D., & Thompson, L.W. (2008). 认知/行为小组干预对减少非西班牙裔白人和西班牙裔/拉丁裔妇女痴呆症家庭照顾者的抑郁症和压力的效果。结果和变化的中介因素。 *理性情绪与认知行为治疗杂志*, 26, 286-303. DOI: 10.1007/S10942-008-0087-4
- Gonzalez, E.W., Polansky, M., Lippa, C.F., Gitlin, L.N., & Zauszniewski, J.A. (2014). 增强明智性以改善家庭照顾者和阿尔茨海默病患者者的结果。一项试点随机试验。 *国际阿尔茨海默病杂志*, 2014年, 323478. DOI:10.1155/2014/323478
- Hopkinson, M.D., Reavell, J., Lane, D.A., & Mallikarjun, P. (2018). 认知行为疗法治疗痴呆症患者护理者的抑郁、焦虑和压力。系统回顾和荟萃分析。 *The Gerontologist*. DOI:10.1093/geront/gnx217
- Kunik, M.E., Snow, A.L., Wilson, N., Amspoker, A.R., Sansgiry, S., Morgan, R.O., ...Stanley, M.A. (2017). 教导痴呆症患者的护理人员解决疼痛问题。 *American Journal of Geriatric Psychiatry*, 25, 144-154. doi:10.1016/j.jagp.2016.04.009
- Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). *压力、评估和应对*. New York, NY:Springer.
- Li, H., Powers, B.A., Melnyk, B.M., McCann, R., Koulouglioti, C., Anson, E., ...Tu, X. (2012). 护理的随机对照试验。改善住院老人和家庭护理人员结果的干预措施。 *护理与健康研究*, 35, 533-549. doi:10.1002/nur.21491
- Li, R., Cooper, C., Austin, A., & Livingston, G. (2013). 应对方式的变化是否解释了对痴呆症患者家庭照顾者的心理发病率干预的有效性? 系统回顾和荟萃分析。 *Doi:10.1017/S1041610212001755*.
- Li, R., Cooper, C., Barber, J., Rapaport, P., Griffin, M., & Livingston, G. (2014). 应对策略是随机对照试验中START(亲属策略)干预对痴呆症患者家庭护理者心理病态的影响的中介因素。 *情感障碍杂志*, 168, 298-305. *Doi:10.1016/j.jad.2014.07.008*
- Li, R., Cooper, C., Bradley, J., Shulman, A., & Livingston, G. (2012). 应对策略和痴呆症患者家庭照顾者的心理发病率。系统回顾和元分析。 *情感障碍杂志*, 139, 1-11. DOI:10.1016/j.jad.2011.05.055
- Liu, Z. (2017). *认知行为干预对痴呆症家庭照顾者心理发病率的有效性。A systematic review and meta-analysis* (博士论文)。可从ProQuest Dissertations & Theses Global数据库获取。(Accession Order No. AAT 10753296)
- López-Martínez, A. (2008). 认为社会支持和应对反应是解释慢性疼痛患者疼痛调整的独立变量。 *DOI:10.1016/j.jpain.2007.12.002*.
- Losada, A., Márquez-González, & Romero-Moreno, R. (2011). 痴呆症护理人员心理干预的行动机制。行为激活的效果和功能失调思想的修改。 *国际老年精神病学杂志*, 26, 1119-1127。
- Losada, A., Márquez-González, M., Romero-Moreno, R., Mausbach, B.T., López, J., Fernández-Fernández, V., & Nogales-gonzález, C. (2015). 认知行为疗法与接受和承诺疗法(ACT)对有明显抑郁症状的痴呆症家庭照顾者的治疗。一项随机临床试验的结果。 *咨询与临床心理学杂志*, 83, 760-772. *Doi:10.1037/ccp0000028*
- Lu, N., Liu, J., Wang, F., & Lou, V.W. (2017). 照顾患有肌肉骨骼疾病的残疾老年人。护理者负担、应对策略和抑郁症状的交易模型。 *老年学和老年医学档案*, 69, 1-7. doi:10.1016/j.archger.2016.11.001
- Mahmoodi, M., Khani, P.M., Banab, B.G., & Bagheri, F. (2016). 团体认知行为疗法对阿尔茨海默病患者家庭照顾者的压力应对策略的效果。 *Salmand*, 11, 190-201. doi:10.21859/sija-1101190
- Murphy, R., Cooper, Z., Hollon, S.D., & Fairburn, C.G. (2009). 心理治疗如何发挥作用? 调研心理治疗的中介因素

- 变化。《行为研究与治疗》, 47, 1-5. doi:10.1016/j.brat.2008.10.001
- Orrell, M., Yates, L., Leung, P., Kang, S., Hoare, Z., Whitaker, C., ...Orgeta, V. (2017).个人认知刺激疗法 (ICST) 对痴呆症患者认知、生活质量、照顾者健康和家庭关系的影响。一个随机的对照试验。《PLoS Medicine》, 14, e1002269. doi:10.1371/journal.pmed.1002269
- Ostwald, S.K., Godwin, K.M., Cron, S.G., Kelley, C.P., Hersch, G., & Davis, S. (2014).基于家庭的心理教育和邮寄的信息计划, 为出院后的卒中护理伴侣提供服务。一个随机的试验。Doi:10.3109/09638288.2013.777806.
- Pan, Y., Jones, P.S., & Winslow, B.W. (2016).中国家庭护理人员的相互性、孝道和抑郁症之间的关系。《Journal of Transcultural Nursing》, 5, 455-463. doi:10.1177/1043659616657877
- Park, E.O., & Schumacher, K.L. (2014).家庭照顾者-照顾者相互性的科学状况。系统回顾。《护理探索》, 21, 140-152.DOI:10.1111/nin.12032
- Rausch, A., Caljouw, M.A., & Es, V.D.P. (2017)。让痴呆症患者和非正式照顾者保持联系。社会心理干预的系统回顾。Doi:10.1017/S1041610216002106.
- Roche, L., Croot, K., MacCann, C., Cramer, B., & Diehl-Schmid, J. (2015)。应对策略在额颞叶痴呆症照顾者的心理结果中的作用。《Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology》, 28, 218-228. doi:10.1177/0891988715588830
- Roche, L., MacCann, C., & Croot, K. (2016).配偶痴呆症照顾者采取应对策略的预测因素。系统回顾。《Alzheimer Disease and Associated Disorders》, 30, 80-91. doi:10.1097/WAD.0000000000000105
- Schinköthe, D., & Wilz, G. (2014).认知行为电话干预研究中的治疗完整性评估与痴呆症照顾者的关系。Doi:10.1080/07317115.2014.886653.
- Shim, B., Landerman, L.R., & Davis, L.L. (2011).阿尔茨海默氏症和帕金森氏症患者的护理人员之间的护理关系相互性的相关因素。《Journal of Advanced Nursing》, 67, 1729- 1738. doi:10.1111/j.1365-2648.2011.05618.x
- Stekhoven, D.J., & Bühlmann, P. (2012).MissForest-非参数化的混合型数据缺失值归集。doi:10.1093/bioinformatics/btr597.
- Waldorff, F.B., Buss, D.V., Eckermann, A., Rasmussen, M.L., Keiding, N., Rishøj, S., ...Waldemar, G. (2012)。社会心理干预对轻度阿尔茨海默病患者的疗效。多中心、评审员盲法、随机的丹麦阿尔茨海默病干预研究 (DAISY)。《BMJ》, 345, e4693. doi:10.1136/bmj.e4693
- Xie, Y. (1998).简化应对方式问卷的可靠性和有效性。《中国临床心理学杂志》, 6, 114-115. Yang, C.T., Liu, H.Y., & Shyu, Y.I. (2014).夫妻关系资源痴呆症患者家庭照顾者的角色压力。一项横断面调查。《国际护理研究杂志》, 51, 593-602. doi:10.1016/j.ijnurstu.2013.09.001
- Yang, Z., Holt, H.K., Fan, J.H., Ma, L., Liu, Y., Chen, W., ...Qiao, Y.L. (2016).在中国农村地区居民中使用中文版迷你精神状态检查的阿尔茨海默病的最佳截断分数。《American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias》, 31, 650-657. doi:10.1177/1533317516662336
- Yu, J., Li, J., & Huang, X. (2012).北京版蒙特利尔认知评估作为轻度认知障碍的简单筛查工具。一个基于社区的研究。《BMC Psychiatry》, 12, 156. doi:10.1186/1471-244X-12-156
- Zauszniewski, J.A., Lekhak, N., & Musil, C.M. (2018)。照顾者对痴呆症状的反应。对应对方式和心理健康的影响。《Issues in Mental Health Nursing》, 39, 382-387. doi:10.1080/01612840.2018.1424974

经版权所有者许可转载。未经许可，禁止进一步复制。